Diskussion 643

Datum: 1931-03-02
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.13

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Martin Svensson (–, man)

Herr talman! Jag har varit med om en reservation, och jag skall med några ord uppehålla mig vid innebörden av denna.

Kungl. Maj:t har föreslagit en begränsning av arbetstiden vid sinnessjukhusen genom en förkortning av densamma från 240 timmar per 28 dagar till 240 timmar per 30 dagar, och då det är nattjänstgöring från 216 timmar per 28 dagar till 216 timmar per 30 dagar. I årets budget har beräknats en kostnadsökning härför till 175,000 kronor samt en viss utökning av personalen. Vid föregående års riksdag var samma fråga uppe till behandling. Chefen för socialdepartementet hade då inte vågat lägga fram det förslag, som nu i år har framlagts. Som motiv hade han anfört, att man inte kunde överblicka de konsekvenser detta beslut komme att ha för landstingens vidkommande. Efter förra årets riksdag har Kungl. Maj:t genom medicinalstyrelsen föranstaltat en utredning om vad kostnaderna skulle kunna bli för våra kroppssjukhus, ifall en motsvarande nedsättning av arbetstiden där komme att genomföras, och utredningen visar, att det skulle bli en årlig kostnad av 2!/, miljoner kronor för landstingen. I det belopp, som här i år beräknats, 175,000 kronor, ligger endast en del av kostnaderna, och man måste ha klart för sig, att åtskilliga nya kostnader komma till. Enligt medicinalstyrelsens beräkning har det upptagits en kostnad av 524,000 kronor per år för de statliga sinnessjukhusen, då beslutet träder fullt i kraft, men i den kostnaden ingår inte vad som erfordras för att utöka bostäderna och skaffa nya bostäder till vissa av dessa befattningshavare. Där är heller inte medräknad den kostnadsökning, som givetvis blir en följd av den utökning av sinnessjukvården, som vi nu hålla på med, då vi ha antagit en tioårig organisationsplan för nybyggnader vid sinnessjukhusen. Då denna organisationsplan antogs, så hade man inte beräknat ett så stort antal befattningshavare, som blir en följd av det beslut, som nu här föreslås. Beträffande konsekvenserna för landstingen kan man ju göra den invändningen, att de inte ha ett ovillkorligt samband med förslaget, och man får väl också i utskottets motivering utläsa den tankegången, när det där säges, att denna personal har ett arbete av säregen beskaffenhet. Men jag tror, att den sjukvårdande verksamheten är för stat och landsting och primärkommuner så sammanflätad, att man inte kommer ifrån att också taga upp spörsmålet om en reglering av arbetstiden även för personalen i landstingens och primärkommunernas sjukvårdsverksamhet. För övrigt ha ju dessa också delvis sinnessjukvård

och vård av de sinnesslöa på sin lott.

Om det statsfinansiella läget hade varit sådant, att man inte behövt så kraftigt hävda sparsamhetssynpunkterna, så hade jag också för min del kunnat

vara med om det förslag, som här föreligger, men med hänsyn till både det statsfinansiella läget och de konsekvenser, som jag tror, att saken kommer att få för landstingens del, där den kommer att aktualisera frågan om arbetstiden för sjukvårdspersonalen och i viss mån bli normerande, så har jag biträtt den vid punkten fogade reservationen, och jag skall, herr talman, be att få yrka bifall till denna av herr Widell m. fl. avgivna reservation, vilken innebär, att kostnadssumman skulle minskas med 175,000 kronor och att personalen också skulle bli mindre till antalet: således 821 skötare och 943 **sköterskor**[3]. Herr talman! Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

2. Alfred Petren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Som avdelningens vice ordförande nämnde, gäller Kungl. Maj:ts förslag en nedsättning av arbetstiden för den lägre sjukvårdspersonalen inom sinnessjukvården från 240 timmar per 28 dagar till 240 timmar per 30 dagar — 8 timmar om dagen alltså, men märk väl: vardag såväl som söndag. Jag vill betona detta, att förslaget inte alls innebär, som Jag märkt, att mången har synts tro, en tillämpning av arbetstidslagen för denna personal, ty enligt arbetstidslagen är det 48 arbetstimmar i veckan. Enligt detta förslag återigen är det fråga om 56 arbetstimmar i veckan. Det är ve verket en ganska ringa minskning av arbetstiden, som förslaget innebär.

Nu ha ju reservanterna i själva verket erkänt, att det inte saknas skäl för denna begränsning av arbetstiden. Detta säges ju uttryckligen i reservationen, och enligt mitt förmenande är det synnerligen starka skäl, som kunna anföras för denna minskning i arbetstiden. Ty det är dock en tjänstgöring av psykiskt mycket påfrestande art, som det här gäller. Att gå inne på en avdelning med sinnessjuka så att säga på spänn ständigt och jämt, det är en tjänstgöring, som utan tvivel är mera påfrestande än mången annan tjänstgöring, i varje fall på kroppssjukhusen.

Nu är det ju egentligen två skäl, som den föregående talaren har anfört mot ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Det är dels konsekvenserna för landstingen och dels det nuvarande statsfinansiella läget. Vad beträffar konsekvenserna för landstingen, menar jag, att det ej är nödvändigt att överallt på sjukvårdsanstalterna genomföra samma lägre arbetstid, som detta förslag nu avser att bereda sinnessjukvårdspersonalen. Det finnes naturligtvis på vissa sjukhus tjänstgöring av sådan art, att detta kan vara befogat, men på andra kanske det inte är befogat. Därvidlag kräves nog en individualisering, och varje landsting får naturligtvis lösa den frågan på vart och ett av sina lasarett och sjukhus allt efter omständigheterna. Det är allt, som är att säga om den saken.

Vad den statsfinansiella situationen beträffar, så skulle jag förstå den föregående talaren, om

det här hade gällt en motion, däri det begärdes ett anslag utöver vad Kungl. Maj:t begärt. Men så är ej här förhållandet, utan anslaget är Kungl. Maj:ts förslag, och det har blivit beräknat i finansplanen, och vid det förhållandet tycker jag ej, att det skälet är så starkt.

Det är här talat om, att det framdeles skulle komma att gå till 524,000 kronor om året. Då vill jag framhålla, att detta är ej beräknat på det nuvarande platsantalet, utan för en framtid, då sinnessjukvården blir utbyggd till det större antal platser, som behöves. Med det nuvarande platsantalet på hospitalen är kostnaden beräknad till 365,000 kronor. Och till sist vill jag nämna, att när det här framhålles, att därutöver komma byggnadskostnader, så kan invändas, att dessa utgifter egentligen ej äro några direkta utgifter utan snarare ett kapitalutlägg, som i det närmaste förräntar sig. Jag skall nämna några siffror, som visa detta. Det är nämligen så, att för de bostadshus, som blivit beslutade för **sköterskor**[3] vid de senast beslutade sinnessjukhusen vid Jön-

köping och utanför Umeå, är kostnaden beräknad till cirka 300 tusen kronor, och byggnaden rymmer 66 sköterskerum. Enligt den hyra, som av **sköterskorna**[3] erlägges vid Uppsala hospital, skulle inkomsten per bostadsrum komma att gå upp till omkring 300 kronor per rum. Det skulle alltså bli en inkomst på bortemot 20,000 kronor om året, alltså bortåt 7 procent av anläggningskostnaden. Vi kunna alltså ej tala om att dessa byggnadskostnader äro utgifter i vanlig mening, utan de äro kapitalutlägg för att bereda personalen bostäder på platsen, för vilka den sedan som sagt lämnar hyresersättning.

Jag ber, herr talman, att få på anförda skäl yrka bifall till utskottets hemställan, som är lika med Kungl. Maj:ts förslag.